

我院就医患者对药物相互作用的认知度调查与分析

刘萍^{1,2*}, 陈玉文^{2#}, 何新荣¹, 赵庆大¹(1.解放军总医院药品保障中心中药房,北京市 100853;2.沈阳药科大学工商管理学院,沈阳市 110016)

中图分类号 R95 文献标识码 C 文章编号 1001-0408(2011)21-2011-03

摘要 目的:了解我院患者对药物相互作用的认知度现状,为促进合理用药提供依据。方法:采用问卷调查方式,对我院2008年5—6月就医的门诊患者进行调查,共发放200份问卷,内容包括就医患者服药种数、对药物相互作用了解程度、对药物相互作用知识的需求、取药后会向谁咨询如何合理用药的问题等,以及常见药物相互作用的实例调查。结果:共回收有效问卷178份,其中就医患者中服药1~5种的占被调查人数的53.37%;但对药物相互作用了解的仅占23.03%;有85.40%的人对药物相互作用知识有需求;取药后认为应向临床药师咨询的比例为0;在常见药物相互作用实例调查中,不了解者超过了半数。结论:我院就医患者对药物相互作用认知度不高,应予以重视并采取相关措施。

关键词 药物相互作用;认知度;患者;调查

Investigation and Analysis of the Perception of Patients on Drug Interaction in Our Hospital

LIU Ping, HE Xin-rong, ZHAO Qing-da (Pharmacy of Traditional Chinese Medicine, Drug Guarantee Center, General Hospital of PLA, Beijing 100853, China)

LIU Ping, CHEN Yu-wen (School of Business Administration, Shenyang Pharmaceutical University, Shenyang 110016, China)

ABSTRACT OBJECTIVE: To investigate the perception of patients on drug interaction in our hospital and to provide reference for improving rational use of drugs. METHODS: By questionnaire survey, outpatients of our hospital during May—Jun. in 2008 were investigated. 200 questionnaires involved the number of drug category, drug interaction cognition, drug interaction knowledge, consulting object who answered how to use drugs rationally after getting drugs and case investigation. RESULTS: A total of 178 valid questionnaires were collected. Patients who took 1~5 kinds of drugs accounted for 53.37%, and the proportion of people who understood the drug interaction was 23.03%. 85.40% of patients wanted to discern the drug-drug interaction. No one believed that they should consult clinical pharmacists. In case investigation, more than half of patients didn't understand drug interaction. CONCLUSION: In our hospital, patients have low perception on drug interaction. Great importance should be attached to it and relevant measures should be conducted.

KEY WORDS Drug interaction; Perception; Patients; Investigation

药物相互作用(Drug Interaction)是一个隐蔽、复杂,有潜在危险,又容易被忽略的问题。药物流行病学研究^[1]表明,用药品种数越多越容易发生药物相互作用,联合用药1~5种的,潜在药物相互作用发生率为12.1%,实际不良反应发生率为3.5%;合用6~10种的,潜在药物相互作用发生率为29.0%,实际不良反应发生率为10.0%;合用11~15种的,潜在药物相互作用发生率为44.8%,实际不良反应发生率为28.0%。目前我国关于药品不良反应的认知度呈逐渐上升趋势^[2,3],但还没有一个关于民众对药物相互作用认知度的摸底调查,说明国民甚至政府相关部门还未十分重视此问题。为了解医院患者对药物相互作用知识、态度和行为的认知现状,分析其影响因素,笔者对我院就医的患者进行了一次药物相互作用认知度调查,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 资料

*主任药师。研究方向:临床药学。电话:010-66936427。E-mail:liuping0707@yahoo.com.cn

#通讯作者:教授,硕士研究生导师。研究方向:药事管理。电话:024-23986552

随机选取2008年5—6月来我院就医的门诊患者进行问卷调查。

1.2 方法

针对社会比较关注的10类问题自行设计了问卷调查表。调查内容包括就医患者服药种数、对药物相互作用了解程度、对药物相互作用知识的需求、取药后会向谁咨询如何合理用药的问题,并分别列出了4组不应同时使用的常用化学药、5组不能同时使用的中药、5组不能同时使用的中药与化学药、5组不能同时使用的中药与食物,请患者选择哪2种不能同时使用并进行回答。所有问题请患者无顾虑如实进行填写。调查数据采用Excel软件进行处理。

2 结果

2.1 患者基本情况

本次调查共发放问卷200份,收回有效问卷178份,有效率为89.00%。被调查患者基本情况统计结果见表1。

2.2 就医患者服药种数

178位患者中回答“尚未吃药”的57人,占总调查人数的32.02%。“正在服用药物治疗”的121人(68.00%),其中每日服用1~2种的52人(29.21%),服用3~5种的43人(24.16%),服

表1 患者基本情况统计结果

Tab 1 General information of patients

特征	项目	样本数/n	构成比/%
性别	男	101	56.74
	女	77	43.26
文化程度	博士	3	1.69
	硕士	6	3.37
	大学	119	67.12
	高中	35	19.39
	初中及以下	15	8.43
工作单位或职业分布	国家机关	17	9.55
	军人	51	28.65
	企业	44	24.72
	事业单位	33	18.54
	学校教师与学生	6	3.37
	其他	27	15.17
年龄分布	18岁以下	2	1.12
	19~28岁(含)	38	21.35
	29~38岁(含)	32	17.98
	39~48岁(含)	27	15.17
	49~58岁(含)	29	16.29
	59岁以上	50	28.09

用6~10种的12人(6.74%),服用10种以上的4人(2.25%)。

2.3 对药物相互作用了解程度

对“您了解药物相互作用吗?”一项回答“了解极少”(102人)及“不了解”(30人)的占总调查人数的74.16%;“比较了解”的36人(20.22%);“非常了解”的仅5人(2.81%),但查阅这5人的答卷,对答卷中所问及的药物相互作用问题回答并不理想。

当问到“您了解哪方面的药物相互作用?”时,回答“了解中药与中药之间相互作用”的33人(18.54%);回答“了解化学药与中草药之间相互作用”的23人(12.92%);回答“了解化学药与中成药之间相互作用”的30人(16.85%);回答“化学药之间相互作用”的42人(23.60%)(以上选项中有5人有≥2项的重复选择);认为“哪方面都不了解”的64人(35.60%)。

2.4 对药物相互作用知识的需求

对“您需要此方面的指导吗?”一项回答“非常需要”(76人)与“希望了解”(76人)的占总调查人数的85.39%;回答“需要时再说”的18人(10.11%);回答“自己能正确用药”的3人(1.69%);未填写的有5人(2.81%);“完全不关心”的0人。

2.5 咨询取向

在问卷中了解了患者在医院取药后会向谁咨询如何合理用药的问题(可以多选),绝大多数回答“向给自己开处方的医师咨询”(98人),占总调查人数的55.06%,说明了患者对医师的信任。回答“向发药的药师咨询”的50人(28.09%),“向咨询台咨询”的22人(12.36%),“询问其他患者”的7人(3.93%),“回去问邻居”的1人(0.56%)。而问卷中回答“向临床药师咨询”的比例为0。

在进行患者了解药物相互作用渠道的调查回答中,患者认为了解这方面的途径主要是“通过医师诊室了解”的66人(37.08%),其实在实际工作中医师较为繁忙,根本无暇顾及对非熟悉专业问题的提问;而通过“报纸”(65人,36.52%)、“电视”(54人,30.34%)、“网络”(20人,11.24%)、“周围的人”(21

人,11.80%)等方式了解药物的相互作用易使患者受到误导。此调查结果说明有相当一部分患者在药物相互作用了解渠道上还存在盲目性。

2.6 对常见药物相互作用的实例调查

2.6.1 对4组可发生药物相互作用的化学药的了解情况见表2。

表2 对4组可发生药物相互作用的化学药的了解情况

Tab 2 Understanding of chemical drugs that may cause drug interaction in 4 groups

药物名称	了解人数/n	构成比/%
阿莫西林 ^[4] 与阿奇霉素	53	29.78
吉非贝齐 ^[5] 与辛伐他汀	9	5.06
西咪替丁 ^[6] 与二甲双胍	12	6.74
米贝拉地尔 ^[7] 与美托洛尔	9	5.06

调查中,4组化学药间的相互作用“都不了解”的95人(52.81%)。

2.6.2 对5组可发生药物相互作用的中药的了解情况^[8]见表3。

表3 对5组可发生药物相互作用的中药的了解情况

Tab 3 Understanding of traditional Chinese medicine that may cause drug interaction in 5 groups

药物名称	了解人数/n	构成比/%
附子与瓜蒌	12	6.74
白芍与藜芦	12	6.74
甘草与海藻	28	15.73
止咳橘红丸与附子理中丸	19	10.67
六味地黄丸与牛黄解毒丸	47	26.40

调查中,5组中药间的相互作用“都不了解”的92人(51.69%)。

2.6.3 对5组可发生药物相互作用的化学药与中药联合应用的了解情况见表4。

表4 对5组可发生药物相互作用的化学药与中药联合应用的了解情况

Tab 4 Combination of chemical drugs and traditional Chinese medicine that may cause drug interaction in 5 groups

药物名称	了解人数/n	构成比/%
红霉素 ^[9] 与含重金属离子的中药	9	5.05
复方铝酸铋片 ^[10] 与丹参	15	8.43
维生素C ^[10] 与黄芩	9	5.06
阿司匹林 ^[11] 与甘草	15	8.43
复方利血平氨苯蝶啶片与麻黄 ^[11]	32	17.98

调查中,5组化学药与中药间的相互作用中每组药的联合应用都只有少部分人了解,“都不了解”的108人(60.67%)。

2.6.4 对5组可发生相互作用的药物与食物的了解情况见表5。

众所周知,中医理论中有药物与食物的禁忌^[12],这一点亦符合药物相互作用定义。此次问卷中,对可发生相互作用的药物与食物^[9]进行了调查,选择“比较了解”的多是长期在我院服用中药的患者,因为药师会对其进行相关知识的告知;但是“不了解”的90人(50.56%),比例也较高,可能是由于目前应用化学药的人员较多所致。

2.7 对开设合理用药咨询台需求的调查结果

表5 对5组可发生相互作用的药物与食物的了解情况

Tab 5 Understanding of drug and food that may cause interaction in 5 groups

药物名称	食物名称	了解人数/ <i>n</i>	构成比/%
丹参	醋	12	6.74
桔梗	猪肉	13	7.30
土茯苓	茶水	18	10.11
薄荷	螃蟹	39	21.91
西洋参	萝卜	35	19.66

对开设合理用药咨询台这一项目除10人没有填写意见,7人认为“可有可无”外,大部分的人都认为“非常必要”(161人,90.45%),认为咨询台“没什么用处”的0人。

3 讨论与结论

由于我院患者群基本稳定,每日的门诊患者有1万余人,在我国政策暂无变化的情况下,笔者所选取的2008年内2个月的样本数来进行考察的结果也是适用的,能说明调查情况。

由调查结果可知,被调查者的性别、年龄及职业分布均匀,说明结果可信;虽然被调查者学历偏向高层次(大学程度及以上占72.18%),但对调查表中所列出的有关药物相互作用知识的了解者甚少,表明文化程度与该调查问题无关,说明对患者进行药物相互作用教育具有重要性和迫切性。

由于目前医院以药养医、多开药才能对医院多作贡献等根本问题并没有解决;同时存在有特殊人群如老年人多种疾病导致用药品种增加、小医院对处方者培训力度不够,以及随着医院分科越来越细,患者就存在多科看病、分别开药等问题。综上,即为医师所开处方的药品品种多、用药剂量大的原因。

中药与化学药联合应用治疗疾病已成为目前重要的治疗手段,并呈现日益增加的趋势。我院中药与化学药同时应用的比例高达61%,特别是高干患者人群,很多患者都是中药与化学药同时大量、长期“保驾式”应用。大量的实例证明,中药与化学药联合应用同样面临着药物相互作用的问题。只有在我国相关部门和中西医工作者的重视与共同努力下才能解决。

2006年美国食品与药物管理局(FDA)、药物评价和研究中心(CDER)及生物制品评价和研究中心(CBER)共同发布了“药物相互作用研究——实验设计、数据分析及其在剂量调整和处方标签中的应用(草案)”指南^[12]。该指南强调新药和生物制品的研发要提供药物代谢和药物转运方面的体内、外相互作用研究。国外许多药厂在新药申报材料中,必须提供这方面的研究结果,药品说明书中要专设“药物相互作用”一栏,对该药的药物相互作用要进行详细的叙述。我国很多药物特别是中药根本没有进行此方面的研究。故相关企业应逐渐加大药物相互作用基础研究的力度。

随着医院药学服务模式的改变,药师已经从窗口后面走

了出来,由单纯发药转变为直接面向患者服务。但很多药师由于自身知识面狭窄使得对患者的用药指导不够,我国临床药师的配备及临床药学的发展都与发达国家存在较大差距,加之新药层出不穷,也使医药工作者应接不暇。医学院校对药物相互作用的系统研究与教学也尚属空白。故我国应加大药师的专业知识培训的力度。

本次调查结果显示,患者对药物相互作用认知度不高,对药物相互作用知识了解甚少。与对药品不良反应的发现和干预比较,国家对药物相互作用重视不够,建议应该早日制定药品不良相互作用预案,投入资金、人力进行深入研究。各医疗单位也应经常组织多学科的大型药物安全利用讨论会,及时给患者以明确指导,对可能产生有害后果而又必须联合应用的药品进行预警和干预。

参考文献

[1] 周元瑶. 药物流行病学[M]. 第1版. 北京: 中国医药科技出版社, 1996: 5.

[2] 徐艳艳, 尹桃. 门诊患者药品不良反应认知度调查[J]. 中国药房, 2008, 19(14): 1 117.

[3] 覃正碧, 郑丽祥, 向继洲, 等. 对基层医药人员药品不良反应报告与监测认知度的调查[J]. 医药导报, 2007, 26(3): 326.

[4] 于秋影, 石磊, 孟丽霞, 等. 我院处方评价及结果分析[J]. 中国医院用药评价与分析, 2010, 10(3): 277.

[5] Graham DJ, Staffa JA, Shatin D, et al. Incidence of hospitalized rhabdomyolysis in patients treated with lipid-lowering drugs[J]. JAMA, 2004, 292(21): 2 585.

[6] 佚名. 降血糖药不可滥用[J]. 中国社区医师, 2008, 24(10): 58.

[7] Mullins ME, Horowitz BZ, Linden DH, et al. Life-threatening interaction of mibefradil and beta-blockers with dihydropyridine calcium channel blockers[J]. JAMA, 1998, 280(2): 157.

[8] 高学敏. 中药学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2007: 40.

[9] 李有才. 常用中西药物配伍禁忌[J]. 中国社区医师, 2004, 20(11): 26.

[10] 周顺, 藤树忠. 中西药联用对临床疗效的影响[J]. 中国现代医生, 2008, 46(8): 100.

[11] 陶维良, 常小红, 李静. 呼吸系统药物相互作用评价[J]. 中国医院用药评价与分析, 2008, 8(3): 174.

[12] 刘治军, 傅得兴, 汤光. FDA 药物相互作用研究指南(草案)2006版解读[J]. 国际药学研究杂志, 2008, 35(1): 50.

(收稿日期: 2010-07-19 修回日期: 2011-03-17)